« Celui qui éclaire les autres fait briller la vertu ; celui qui ramène les êtres au Dao les libère de la confusion. Sortir de l'ombre, c'est revenir à la Lumière du Ciel. » (Dao De Jing, ch. 10, 33, 62).

SOMMAIRE

Préface……P.13

Avant-propos……..P.16
Introduction……P.34

PARTIE-I : FONDEMENTS COSMO-SPIRITUELS CHINOIS……...P.41

Chapitre 1 : Cosmologie et monde invisible……P.42

Chapitre 2 – Anthropologie spirituelle chinoise……P.71

Chapitre 3 – Faute, karma, malédictions et désordre énergétique……..P.106

PARTIE II – PHÉNOMÈNES OCCULTES ET POSSESSIFS EN CONTEXTE CHINOIS……P.129

Chapitre 4 – Typologie des pratiques occultes chinoises……..P.130

Chapitre 5 – Symptomatologie clinique du handicap spirituel……..P.152

Chapitre 6 – Diagnostic différentiel : MTC, psychiatrie et MTHS……P.176

PARTIE III – CLINIQUE DU DÉSENVOÛTEMENT SELON LA MTHS…..P.202

Chapitre 7 –Identification et preuve clinique de l'envoûtement……P.203

Chapitre 8 –Contention thérapeutique et sécurisation du patient……P.227

Chapitre 9 –Confession thérapeutique et dévoilement des pactes……..P.248

Chapitre 10 –Anéantissement de l'envoûtement……P.263

Chapitre 11 –Rééducation, resocialisation et prévention……...…P.282

PARTIE IV – THÉRAPEUTIQUES CHINOISES DE LIBÉRATION SPIRITUELLE……P.302
Chapitre 12 – Acupuncture spirituelle et pharmacopée rituelle……P.303 12

Chapitre 13 – Rituels taoïstes d'exorcisme……P.326

Chapitre 14 – Maîtrise des esprits et restauration du destin (Ming)……P.344

PARTIE V – DIALOGUE THÉOLOGIQUE CHINE – CHRISTIANISME – MTHS……P.364

Chapitre 15 – Christ, accomplissement du Dao…….P.365

Chapitre 16 – Esprit Saint et Qi divin……P.396

Chapitre 17 – Sacrements et thérapie de rupture des pactes……..P.423

PARTIE VI – ÉTUDES DE CAS ET PROTOCOLES CLINIQUES……..P.446

Chapitre 18 – Études de cas cliniques commentées……P.447

Chapitre 19 – Malédictions ancestrales et libération transgénérationnelle…….P.470

Chapitre 20 – Protocoles complets MTHS……..P.494

PARTIE VII – DIMENSION INSTITUTIONNELLE, SOCIALE ET MISSIONNAIRE……P.525

Chapitre 21 – Formation et certification des cliniciens MTHS……..P.526

Chapitre 22 – Centres de réhabilitation des handicapés spirituels……..P.554

Chapitre 23 – Contribution à la paix sociale et au dialogue interreligieux..P.574

CONCLUSION GÉNÉRALE……P.593

Localisation du Siège social de l'ASMAB……P.602

PREFACE

Il existe des blessures que les yeux ne voient pas, des cicatrices qui ne se lisent pas sur la peau, des entraves qui ne se mesurent ni au thermomètre, ni à l'IRM, ni au rythme cardiaque. Elles sont silencieuses, parfois invisibles, mais elles traversent l'être entier : l'âme, le corps, le destin et la relation à l'autre. Certaines de ces blessures prennent racine dans des expériences humaines universelles : la peur, le rejet, le traumatisme ou l'injustice. D'autres proviennent de forces dont nous ignorons l'origine mais dont les effets sont tangibles : influences occultes, envoûtements, parasitages énergétiques, désalignements du Ming, ces lignes invisibles qui régissent le cours de la vie dans l'anthropologie chinoise.

Depuis des millénaires, les grandes traditions spirituelles ont reconnu cette dimension de la souffrance humaine. Les monastères taoïstes, les temples confucéens, les sociétés rituelles africaines ou les ordres chrétiens ont toutes élaboré des pratiques de protection, de purification et de restauration. Pourtant, dans notre monde contemporain, marqué par l'essor de la science biomédicale et la rationalisation des pratiques spirituelles, ces souffrances invisibles sont souvent niées, incomprises, marginalisées. Et lorsque la peur ou l'ignorance s'en mêlent, les victimes deviennent doubles : victimes de la blessure et victimes du silence social et médical.

C'est précisément pour répondre à cette urgence spirituelle et humaine que l'Association Mariale d'Abili (ASMAB) a conçu la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS). Elle ne 14 se contente pas de proposer un modèle de délivrance ou un protocole de désenvoûtement ; elle offre une approche intégrative, profondément réfléchie, qui unit discernement théologique, observation clinique, anthropologie médicale chinoise et inculturation respectueuse des traditions locales. La MTHS part d'un postulat simple mais radical : on ne libère pas un esprit sans restaurer la personne tout entière. Elle reconnaît que l'être humain ne peut être réduit à une dimension unique : corps, âme et esprit interagissent, se blessent, se restaurent.

Dans ce livre, la religion traditionnelle chinoise est mise en dialogue avec la théologie chrétienne et la pratique clinique contemporaine. Les rituels de purification, les techniques d'harmonisation énergétique, l'étude des flux du Shen, du Hun et du Po, ne sont pas présentés comme des exotismes ou des curiosités culturelles, mais comme des outils précis, éprouvés et éthiquement encadrés, capables de restaurer la cohérence intérieure et de prévenir les blessures transgénérationnelles. Chaque chapitre, chaque protocole, chaque réflexion est imprégné de cette conviction : la libération est à la fois un droit fondamental de l'être et une responsabilité collective des praticiens, des familles et des communautés.

Ce livre se veut également initiatique. Le lecteur n'est pas seulement invité à comprendre, il est invité à traverser un chemin de discernement : reconnaître la complexité du spirituel, accepter la profondeur des blessures, et mesurer la gravité de toute intervention sur l'âme humaine. La MTHS ne s'offre pas comme un 15 spectacle ou une démonstration ; elle se révèle comme un art exigeant, où patience, humilité et respect sont les conditions sine qua non de la transformation intérieure.

Enfin, ce travail affirme une vocation universelle. Bien que profondément enraciné dans la culture chinoise et éclairé par la théologie chrétienne, il ouvre la voie à une médecine spirituelle interreligieuse, capable de dialoguer avec toutes les traditions, de respecter toutes les cosmologies, et d'offrir à chaque être humain la possibilité d'une libération intégrale, respectueuse de sa dignité et de son histoire. L'ASMAB, en portant cette initiative, assume ainsi une responsabilité prophétique : témoigner d'un possible, révéler un chemin, et inviter la communauté des praticiens et des chercheurs à faire de la libération spirituelle une œuvre collective, éthique et durable.

Que ce livre serve de guide, de référence et d'inspiration. Qu'il éveillé la conscience des praticiens, soutienne les familles et éclaire les chercheurs. Mais surtout, qu'il montre à chaque lecteur que là où la souffrance invisible semble inéluctable, il existe toujours une voie de réconciliation, d'unité et de paix intérieure. La Médecine Traditionnelle des Handicapés

Spirituels n’est pas seulement un savoir : c’est une expérience de vie, de transformation et de responsabilité.

,

E

D

I

T

E

U

R

AVANT-PROPOS

I- DE LA DEVIANCE SPIRITUELLE MONDIALE AU CONCEPT DE HANDICAP SPIRITUEL

À l'aube du XXIe siècle, l'humanité se découvre technologiquement puissante mais spirituellement vulnérable. Jamais les moyens de communication n'ont été aussi rapides, jamais la science biomédicale n'a été aussi précise, et pourtant, jamais l'angoisse intérieure, la fragmentation de l'âme et les pathologies du sens n'ont été aussi répandues. Derrière les crises économiques, les conflits armés, les déséquilibres écologiques et les effondrements sociaux se profile une réalité plus profonde, souvent occultée par les analyses purement sociopolitiques : une crise du lien spirituel, une déviance silencieuse mais massive de la relation de l'homme à l'invisible, au sacré, à l'ordre cosmique et à Dieu.

La théologie chrétienne nomme cette rupture « mystère d'iniquité », l'anthropologie africaine parle de « désordre des alliances », et la tradition chinoise l'interprète comme une perte d'harmonie entre le Ciel (Tian), la Terre (Di) et l'Homme (Ren). Ces trois lectures convergent vers un même constat : l'homme moderne, déraciné de ses fondements spirituels, est devenu un être exposé aux forces de confusion, aux intrusions obscures, aux pactes inconscients et aux déséquilibres énergétiques qui affectent son âme autant que son corps.

Dans ce contexte, la sorcellerie, les pratiques occultes, les manipulations énergétiques, les cultes déviants, les invocations d'esprits errants et les technologies spirituelles destructrices ne sont plus des phénomènes localisés. Elles traversent les continents, s'infiltrent dans les villes globalisées, se dissimulent sous des langages pseudo-scientifiques ou thérapeutiques, et produisent une multitude de victimes que la biomédecine ne parvient pas à expliquer ni à soulager pleinement. L'Occident parle de troubles dissociatifs, l'Afrique de persécutions mystiques, la Chine de perturbations du Shen et d'attaques de Qi pervers, tandis que l'Église discerne des formes d'oppression et de possession.

C’est dans cet entrelacs de diagnostics partiels qu’émerge la notion de déviance spirituelle mondiale. Elle ne désigne pas seulement des comportements moralement répréhensibles, mais un état de désalignement profond de l’être humain par rapport à son axe transcendant. L’homme ne vit plus « sous le Ciel » au sens taoïste, ni « devant Dieu » au sens biblique, ni « dans la communion des ancêtres » au sens africain. Il devient un être fragmenté, errant entre plusieurs registres de réalité, vulnérable aux forces qui exploitent ses brèches intérieures.

Dans la cosmologie chinoise, lorsque le Qi ne circule plus harmonieusement, lorsque le Shen se trouble et lorsque les âmes Hun et Po se désaccordent, l’individu devient perméable aux influences du Yin sombre. Des entités errantes, des mémoires karmiques, des forces de désordre peuvent alors s’attacher à lui, provoquant maladies, troubles mentaux, malchance chronique, 18 ruptures relationnelles et effondrement du destin (Ming). Cette lecture rejoint l’anthropologie spirituelle africaine, qui voit dans la sorcellerie et les malédictions des intrusions d’énergies et d’esprits étrangers dans le champ vital de la personne.

La théologie chrétienne, quant à elle, situe ces phénomènes dans le combat entre le Royaume de Dieu et les puissances des ténèbres. Le péché, compris non seulement comme transgression morale mais comme ouverture de brèches spirituelles, crée des zones d’ombre où l’Adversaire peut établir des droits d’oppression. La délivrance devient alors un acte de restauration de la seigneurie du Christ sur l’être tout entier.

C’est dans ce carrefour de lectures que la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) propose un concept central : celui de handicap spirituel. Par analogie avec le handicap physique ou mental, il désigne une altération durable des fonctions spirituelles de la personne, c’est-à-dire de ses capacités à discerner, à se relier au divin, à résister aux forces de destruction, à orienter sa vie selon l’ordre cosmique et moral.

Le handicap spirituel n’est pas une simple faiblesse de foi, ni une crise passagère. Il est l’effet d’une atteinte structurelle de l’âme, souvent liée à :

- des pactes occultes conscients ou inconscients,
- des héritages transgénérationnels de sorcellerie,
- des traumatismes mystiques,
- des initiations déviantes,
- des agressions spirituelles prolongées

Dans le langage chinois, on pourrait parler d'une lésion du Shen, d'une fragmentation des âmes Hun et Po, d'un effondrement du Jing et d'une invasion du champ énergétique par des Qi pervers. Dans la théologie chrétienne, on évoquerait une aliénation, une captivité, une servitude spirituelle. Dans l'anthropologie africaine, on parlerait de « personne liée », « mangée » ou « confisquée » par les forces occultes.

La MTHS opère alors une synthèse clinique : le handicap spirituel est une pathologie du lien à Dieu, au Ciel, aux ancêtres justes et à soi-même, qui se manifeste par des symptômes psychiques, corporels, sociaux et existentiels. Il nécessite une thérapie spécifique : le désenvoûtement, entendu non comme un simple rite, mais comme un processus de conversion, de libération et de restauration ontologique.

Cette thérapie ne peut être improvisée. Elle requiert une méthodologie rigoureuse, comparable à celle d'une médecine spécialisée, avec ses diagnostics, ses protocoles, ses étapes, ses critères de guérison et de réinsertion. C'est ici que la MTHS articule les apports de la théologie de la délivrance, des savoirs africains et de l'anthropologie médicale chinoise, en vue d'une clinique interreligieuse de la restauration de l'homme.

Dans la sagesse chinoise, guérir, ce n'est pas seulement chasser un esprit, mais réharmoniser l'ensemble du système cosmique personnel : restaurer la circulation du Qi, pacifier les âmes, réaligner l'homme avec le Ciel, purifier les mémoires et refermer les portes par lesquelles les forces obscures s'étaient introduites. Cette vision rejoint profondément la dynamique du

désenvoûtement MTHS, qui ne se limite pas à l'expulsion, mais vise la reconstruction intérieure, la rééducation spirituelle et la réintégration sociale.

Ainsi, avant même de détailler les protocoles, l'introduction pose un principe fondamental : la délivrance n'est pas un acte isolé, mais un chemin initiatique de retour à la lumière, un passage de l'obscurité à la clarté, de la servitude à la filiation, de la dispersion à l'unité intérieure. C'est ce chemin que ce livre se propose de décrire, en croisant les langages du Dao, de la sagesse africaine et de l'Évangile, sous l'éclairage clinique de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels.

II- METHODOLOGIE CLINIQUE MTHS ET LES 5 ETAPES DU DESENVOUTEMENT

Après avoir posé les fondements de la problématique mondiale de la déviance spirituelle et défini le concept de handicap spirituel, il est essentiel d'exposer la méthodologie clinique de la MTHS et de détailler les 5 étapes thérapeutiques du désenvoûtement, qui constituent le cœur de la pratique initiatique et de la délivrance intégrale.

1. La méthodologie clinique MTHS : une approche intégrale

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) ne se limite pas à une approche rituelle ou exorcistique : elle est une science clinique du spirituel, capable d'articuler observation, diagnostic, traitement et réintégration. Son originalité réside dans la synthèse des sagesses traditionnelles africaines, chinoises et chrétiennes, articulée selon une démarche scientifique et éthique.

1.1 Observation et discernement

L'observation est la première étape. Le thérapeute MTHS ne se contente pas de constater des symptômes superficiels : il scrute le corps, l'âme et l'environnement du patient. Dans la lecture chinoise, cela correspond à l'analyse du Qi, du Shen, des âme Hun et Po et de l'harmonie entre les cinq éléments (Wu Xing). En Afrique, on observe les signes d'attaques spirituelles, de pactes occultes et de ruptures relationnelles. Dans la théologie chrétienne,

le discernement se focalise sur la présence d'oppressions démoniaques et la capacité de l'âme à se relier à Dieu.

1.2 Diagnostic clinique

Le diagnostic MTHS est multidimensionnel :

- Physique : troubles psychosomatiques, fatigue inexpliquée, maladies chroniques.

- Psychique : anxiété persistante, cauchemars, visions oppressantes, confusion mentale.

- Spirituel : altération de la conscience morale, impossibilité de prier ou de méditer, attachements à des pratiques occultes.

- Social : isolement, conflits familiaux, marginalisation communautaire. Ce diagnostic repose sur l'expérience clinique, le témoignage du patient, l'analyse des influences ancestrales et l'interprétation énergétique des désordres selon la tradition chinoise. L'objectif est de déterminer l'origine du handicap spirituel et la profondeur de la fracture dans le champ spirituel de l'individu.

1.3 Planification thérapeutique

Chaque séance de MTHS s'inscrit dans un protocole précis, intégrant :

- Préparation spirituelle : prière, purification de l'espace, invocation des forces célestes et bienveillantes.

- Engagement moral du patient : acceptation de la guidance, volonté de transformation et ouverture au rétablissement de l'harmonie.

- Structuration du traitement : séquences rituelles, purification énergétique, interventions cliniques et suivi postthérapeutique. Le plan thérapeutique n'est pas standardisé mais adapté à la réalité culturelle et spirituelle de chaque patient, respectant les paradigmes chinois, africains et chrétiens.